



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
REFRESHMENT KETERAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN DAN PELEPASAN
KATETER URIN
TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



**TOR (TERM OF REFERENCE)
REFRESHMENT KETERAMPILAN KLINIK
PEMASANGAN DAN PELEPASAN KATETER URIN
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi selalu mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) di setiap prosedur tindakan klinis. Salah satu tindakan kompetensi dasar yang sering dilakukan oleh perawat di ruang rawat inap adalah pemasangan dan pelepasan kateter urine. Meskipun tergolong tindakan sehari-hari, setiap tahapan dalam prosedur ini memiliki risiko komplikasi yang signifikan jika tidak dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku.

Baru-baru ini, ditemukan insiden keselamatan pasien terkait proses pelepasan kateter urine. Terjadi kasus kesulitan pelepasan selang kateter yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengidentifikasi dan mencatat volume air steril (aquabidest) yang digunakan sebagai pengunci balon kateter saat pemasangan. Akibatnya, saat akan dilakukan pelepasan, volume cairan yang ditarik tidak sesuai dengan jumlah pengunci yang masuk.

Ketidakpatuhan dan ketidaktepatan dalam menjalankan teknik pelepasan yang sesuai SOP ini berdampak fatal, di mana balon kateter gagal mengempis sepenuhnya dan menyebabkan kesulitan dalam melepas kateter. Dampak klinis dari insiden ini sangat berat, hingga mengharuskan pasien menjalani tindakan operatif (pembedahan) untuk mengeluarkan kateter tersebut. Kejadian ini tidak hanya menurunkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga meningkatkan *length of stay* (hari rawat), biaya perawatan, serta risiko tuntutan hukum bagi fasilitas kesehatan.

Evaluasi mendalam terhadap insiden tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali pemahaman materi, kedisiplinan pencatatan (dokumentasi volume pengunci), dan penajaman keterampilan klinis perawat. Oleh karena itu, Komite Keperawatan memandang perlu untuk upaya peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan Diklat "Refreshment Pemasangan dan Pelepasan Kateter" sebagai bagian dari pemenuhan dan pemeliharaan Rincian Kewenangan Klinis.

Melalui kegiatan diklat ini diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan pemasangan maupun pelepasan kateter sesuai SPO, prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), sasaran keselamatan pasien, serta standar praktik keperawatan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan tindakan kateterisasi dapat dilakukan secara kompeten, aman, efektif, dan sesuai dengan kewenangan klinis yang dimiliki, sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit.
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 113.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Sasaran Keselamatan Pasien.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Refreshment Pemasangan dan Pelepasan Kateter di Rumah Sakit diadakan dengan tujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman, meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, serta menajamkan keterampilan klinis peserta mengenai teknik pemasangan dan pelepasan kateter urine yang aman.
2. Tujuan
 - a. Tujuan Umum
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapat dari *refreshment* ini dalam kegiatan pelayanan keperawatan guna memastikan prosedur pemasangan dan pelepasan kateter berjalan dengan aman dan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
 - b. Tujuan Khusus
 - 1) **Keselamatan Pasien:** Mencegah terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) berupa trauma saluran kemih akibat kegagalan prosedur pelepasan kateter.
 - 2) **Kepatuhan Dokumentasi Klinis:** Meningkatkan kedisiplinan perawat dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mendokumentasikan volume cairan pengunci (aquabidest) balon kateter secara akurat di rekam medis saat pemasangan.
 - 3) **Kepatuhan Standar Prosedur Operasional (SOP):** Memastikan perawat melakukan penatalaksanaan pelepasan kateter secara teliti sesuai SOP.
 - 4) **Mutu Efisiensi Pelayanan:** Meminimalkan risiko komplikasi berat yang dapat berdampak pada tindakan operatif (pembedahan), sehingga mampu menekan angka hari rawat (*length of stay*) dan biaya perawatan tambahan bagi pasien.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia

Tabel 2.1.1 Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ



2	Sekretaris	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
3	Moderator	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.	bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir: ringkasan persepsi dan tanya jawab
4	Absensi	Ns. Debi Firmanasia, S.Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelatihan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan
5	Sie Dokumentasi	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir: foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	Ns. Debi Firmanasia, S.Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambil alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	Ns. Debi Firmanasia, S.Kep	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
8	Sie Pretest dan Posttest	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.	bertanggung jawab terhadap pembagian, pelaksanaan, penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test

2.2 Rencana Penyelenggaraan

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026

Waktu : 10.00-12.00 WIB

Tempat : Hall Sakura Lantai 3 RSPHS

Tabel 2.2.1 Tabel Rencana Kegiatan

JUDUL MATERI	SASARAN	NARASUMBER	METODE	PERLENGKAPAN	FREKUENSI PELAKSANAAN	DASAR MATERI	OUTPUT TRAINING	TARGET TRAINING JANGKA PANJANG
Refreshment Pemasangan dan Pelepasan Kateter	1. Perawat 2. Bidan	1. dr. Muhammad Adi Satrio Lazuardi, Sp.U 2. Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep	1. Pre-Post Test 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanya Jawab	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Alat Tulis	1x / tahun	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang	1. Perawat dan bidan mampu memahami kembali anatomi, fisiologi, serta teknik aseptik dalam pemasangan dan pelepasan kateter urine secara benar. 2. Adanya peningkatan kepatuhan 100% terhadap SOP, terutama larangan menarik paksa kateter jika terjadi hambatan pada balon. 3. Terwujudnya kebiasaan pencatatan (dokumentasi) yang akurat mengenai volume cairan pengunci (aquabidest) pada	1. <i>Zero Reporting</i> untuk " <i>Never Events</i> " berupa trauma uretra/saluran kemih akibat kesalahan dalam pelepasan kateter di seluruh ruang rawat inap. 2. Menurunkan angka kejadian infeksi terkait pemasangan alat (<i>Catheter-Associated Urinary Tract Infection / CAUTI</i>) di rumah sakit. 3. Seluruh perawat dan bidan di RS Prima Husada Sukorejo memiliki kompetensi klinis yang tersertifikasi dan terverifikasi secara berkala

						Akreditasi Rumah Sakit. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit. 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 113.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Sasaran Keselamatan Pasien.	rekam medis saat kateter dipasang. 4. Peserta mampu mengidentifikasi tanda-tanda kegagalan pengempisan balon kateter secara dini dan mengetahui alur pelaporan/konsultasi medis sebelum terjadi trauma berat.	dalam penatalaksanaan kateterisasi. 4. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, keselamatan pasien, serta efisiensi biaya akibat perpanjangan hari rawat (<i>length of stay</i>) dari komplikasi tindakan.
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Tabel 2.2.2 Outline Training

NO	OUTLINE	ISI PPT	PJ
1	Barcode Absensi	QR code absensi kehadiran peserta.	MC
2	Pre Test	QR code <i>pre-test</i> dengan pembatasan waktu (estimasi 30 detik per pertanyaan untuk menguji pengetahuan awal tentang SOP kateter).	MC
3	Susunan Acara	Tabel <i>rundown</i> acara <i>training/refreshment</i> .	MC
4	Judul	<i>Refreshment</i> Pemasangan dan Pelepasan Kateter	Narsum
5	Latar Belakang & Case Review	Case Review: Paparan kronologi insiden kesulitan pelepasan kateter akibat kelalaian pencatatan volume pengunci balon dan penarikan tidak sesuai SOP yang berujung pada tindakan operatif. - Penekanan pentingnya patient safety dan kepatuhan SOP 100% untuk mencegah never events.	Narsum
6	Target & Output	- Perawat dan bidan patuh 100% terhadap SOP pemasangan & pelepasan kateter - Kedisiplinan dokumentasi volume cairan pengunci (aquabidest) di rekam medis - Mampu melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan aman saat menemui hambatan pelepasan (tidak ditarik paksa) - Mencapai <i>Zero Reporting</i> untuk insiden trauma uretra akibat kateter	Narsum

7	Konsep Dasar & Anatomi Urologi	1. Review singkat anatomi sistem perkemihan (uretra pria vs wanita) 2. Indikasi dan kontraindikasi pemasangan kateter urine 3. Pemilihan jenis dan ukuran kateter yang tepat sesuai kondisi pasien	Narsum
8	Prosedur Pemasangan & Kunci Balon	1. Teknik aseptik dan sterilitas dalam pemasangan kateter 2. Materi Krusial: Prosedur penguncian balon kateter menggunakan aquabidest dan batas volume aman yang direkomendasikan pabrikan 3. Kewajiban dokumentasi jumlah cc cairan pengunci pada lembar rekam medis pasien	Narsum
9	Prosedur Pelepasan Kateter sesuai SOP	1. Langkah-langkah pelepasan kateter yang aman 2. Teknik memastikan dan menarik kembali cairan pengunci balon secara total hingga balon mengempis sempurna 3. Evaluasi kondisi urine dan respon pasien pasca-pelepasan	Narsum
10	Penatalaksanaan Penyulit & Hambatan	1. Faktor penyebab balon kateter gagal mengempis (kristalisasi cairan, katup spuit rusak, dsb) 2. SOP Kontingensi: Apa yang harus dilakukan perawat jika kateter macet/sulit dilepas (larangan keras menarik paksa) 3. Alur pelaporan dan kolaborasi medis/konsultasi ke Dokter Spesialis Urologi sebelum terjadi trauma jaringan	Narsum
11	Pencegahan Komplikasi & CAUTI	1. Strategi pencegahan Infeksi Saluran Kemih Terkait Kateter (CAUTI) 2. Perawatan kateter harian (catheter care) di ruang rawat inap	Narsum
12	Kesimpulan & Rencana Tindak Lanjut	1. Penekanan kepatuhan SOP sebagai harga mati patient safety 2. Komitmen bersama untuk penulisan volume pengunci balon di status pasien 3. Sosialisasi alur konsultasi urologi jika terjadi penyulit	MC
13	Post Test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

Tabel 2.2.3 Tabel Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

NO	LANGKAH	PJ	YANG TERLIBAT
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	Komite Keperawatan & Kebidanan Hasil materi di CC ke SDM
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	Ns. Debi Firmanansia, S.Kep	

3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	dr. Muhammad Adi Satrio Lazuardi, Sp.U	Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	dr. Muhammad Adi Satrio Lazuardi, Sp.U	Narasumber
5	Menentukan moderator training	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep	Komite Keperawatan
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep	Komite Mutu
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	Komite Mutu
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	Komite Mutu
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep	Panitia

2.3 Sasaran Atau Peserta

Tabel 2.3.1 Sasaran atau Peseerta

NO	Unit	Profesi	Jumlah
1	IGD	Bidan	4
		Perawat	25
2	IRJA	Bidan	3
		Perawat	22
3	IRNA 2A	Perawat	25
4	IRNA 2B	Perawat	21
5	IRNA 3A	Perawat	19
6	IRNA 3B	Perawat	17
7	ICU	Perawat	11
8	Maternitas	Bidan	15
9	NICU	Perawat	9
TOTAL			175

2.4 Susunan Acara Lengkap

Tabel 2.4.1 Susunan Acara

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
10.00-10.15 WIB	10 menit	Pretest	Tim
10.15-11.45 WIB	60 menit	1. Review Anatomi Urogenital & Teknik Aseptik Pemasangan Kateter 2. Prosedur Penguncian Balon Kateter & Batas Volume Aman Aquabidest 3. Penatalaksanaan Balon Macet/Gagal Mengempis 4. Strategi Pencegahan Komplikasi & CAUTI 5. Kesimpulan & Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	dr. Muhammad Adi Satrio Lazuardi, Sp.U
	15 menit	1. Standar Dokumentasi Volume Pengunci pada Rekam Medis 2. SOP Pelepasan Kateter Urine yang Aman 3. Alur Pelaporan dan Konsultasi Klinis Ke Dokter Spesialis Urologi	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep
	15 menit	Asuhan Keperawatan dan Dokumentasi Keperawatan	Ns. Debi Firmanansia, S.Kep
	10 menit	Diskusi dan Tanya Jawab	Tim
11.45-12.00 WIB	10 menit	Post test	Tim

2.5 Narasumber

1. dr. Muhammad Adi Satrio Lazuardi, Sp.U (Materi Klinis)
2. Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep (Materi Asuhan Keperawatan)
3. Ns. Debi Firmanansia, S.Kep

2.6 Media

1. LCD
2. Laptop
3. Sound system

2.7 Metode

1. Pre-Post Test



2. Presentasi
3. Diskusi
4. Tanya Jawab

2.8 Kebutuhan Anggaran

Tabel 2.8.1 Kebutuhan Anggaran

NO.	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN (RP)	HARGA (RP)	SUMBER DANA
1	Fee Pemateri	1	Rp. 250.000	Rp. 250.000	PT.DPM
2	Snack pemateri (dokter)	1 kardus snack, 1 kardus makan + air mineral	Rp 30.000	Rp 30.000	Dapur RSPHS
3	Snack Panitia	3 kardus snack + air mineral	Rp 5.000	Rp 15.000	Dapur RSPHS
3	Aqua gelas	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000	Dapur RSPHS
4	Sertifikat	211	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy oleh SDM
Total				Rp 395.000	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 395.000	

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 Monitoring

Tabel 3.1.1 Monitoring

NO	BAHASAN DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	PJ Training
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	Ketua Panitia
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	Komite Keperawatab

3.2 Evaluasi

Tabel 3.2.1 Evaluasi

No	Materi	Penanggung Jawab
1	Kehadiran peserta a. Jumlah undangan b. Jumlah peserta hadir c. Jumlah peserta tidak hadir d. Ketepatan waktu hadir	Panitia
2	Materi a. Kesesuaian materi dengan tujuan diklat dan RKK b. Kesesuaian materi dengan SPO c. Materi mudah dipahami d. Materi dapat diterapkan di unit kerja	Panitia
3	Narasumber a. Penguasaan materi	



	b. Kemampuan komunikasi c. Ketepatan waktu penyampaian materi	
4	Hasil test a. Nilai pre – test b. Nilai post – test c. Peningkatan nilai d. Presentase kelulusan	Panitia
5	Sertifikat a. Lulus post-test dan praktik b. Ketepatan waktu penerbitan sertifikat	Panitia

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada

Pasuruan, 18 Juli 2026
Ketua Panitia,

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini



Novia Ainur P, S.KM

Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep

Disetujui oleh,
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep